

04 - 04- Cancers de l'Endomètre - Pr. SOUMMANI

Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les cancers de l'endomètre. Les cancers de l'endomètre sont toutes les tumeurs malignes qui se développent à partir de la cavité de l'utérus et dont le point de départ se situe au niveau de l'endomètre. C'est une pathologie de la femme âgée.

Femme, c'est une pathologie de troisième âge. Ce qui veut dire que femme âgée, ça veut dire femme qui pourrait souffrir des affections chroniques cardiovasculaires, diabète, hypertension artérielle, etc. Il faut dire que grâce à l'échographie endovaginale, on a pu améliorer le dépistage des lésions assez tôt.

Tous stades confondus, les cancers de l'endomètre ont un taux de survie à 5 ans qui avoisine les 80%. Quelques objectifs, il faut connaître les facteurs de risque, l'anatomopathologie, il faut savoir diagnostiquer un cancer de l'endomètre, expliquer les bases des classifications qui ont un impact pronostic, proposer une attitude thérapeutique et planifier la surveillance après le traitement. Sur le plan épidémiologique, l'incidence des cancers de l'endomètre est de 10 à 16 pour 100 000 femmes en France.

Il est de 361 000 cas par an aux Etats-Unis. Il est certes moins fréquent que le cancer du col, mais son incidence augmente vu l'augmentation de l'espérance de vie de la femme. L'âge de survenue de cette pathologie est la femme ménopausée.

La femme âgée, comme j'ai dit en introduction, c'est une pathologie du troisième âge. L'âge moyen est de 60 ans et la tranche d'âge la plus touchée se situe entre 50 et 60 ans. Il faut dire également qu'il faut faire attention parce que 20 à 25 % des cancers de l'endomètre surviennent chez la femme avant la ménopause.

Les facteurs de risque de cette pathologie sont d'abord le statut hormonal. C'est une hyper-œstrogénie, soit absolue, due à une tumeur ovarienne sécrétant l'œstrogène, soit un traitement œstrogénique non compensé. Vous savez tous que les femmes ménopausées prennent le traitement substitutif de la ménopause, c'est de l'œstrogène, qu'il faut compenser par la prise de progestérone pour contrecarrer l'effet délétère de l'œstrogène au niveau de l'endomètre.

Si la femme prend de l'œstrogène sans qu'il ne soit compensé par la progestérone, le risque de cancer de l'endomètre est accru. Il y a également une hyper-œstrogénie relative, c'est-à-dire une femme qui a une période d'activité génitale très longue, soit une ménopause très tardive, soit une puberté précoce. Donc l'endomètre est exposé à un effet biologique de l'œstrogène très important.

Il y a également le terrain, c'est des femmes en général qui sont obèses. L'obésité peut générer des œstrogènes à partir de tissus sous-cutanés. Il y a la nulliparité, il y a comme j'ai dit la ménopause tardive, l'alimentation riche en viande, l'hérédité, surtout le syndrome de Lynch, cancer du sein, endomètre, ovaire, le diabète, l'hypertension.

Ici le diabète et l'hypertension peuvent être une pathologie associée vu l'âge de la patiente. Il y a également l'exposition au tamoxifène qui est un médicament qu'on donne chez les femmes présentant un cancer du sein hormonodépendant, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs hormonaux. En général, la femme qui prend du tamoxifène doit être surveillée pour diagnostiquer très tôt un éventuel cancer de l'endomètre.

Donc voilà quelques facteurs de risque, l'obésité, la nulliparité, la ménopause tardive et la puberté précoce, le diabète, l'hypertension artérielle, l'exposition aux œstrogènes seules, le tamoxifène, on ne sait pas pour les ovaires polycystiques. La contraception orale aurait un effet bénéfique et le tabac, mais il faut dire que ce sont des statistiques. Sur le plan anatomopathologique, sur le plan macroscopique, la tumeur peut être un bourgeon, une végétation bourgeonnante au niveau de la cavité de l'utérus ou bien une érosion de l'endomètre ou bien un simple polype d'allure banale qui cache un cancer de l'endomètre ou un aspect polyploïde de l'endomètre.

Sur le plan microscopique, les types histologiques sont nombreux. Il y a deux types qui sont importants et ici c'est d'abord le type 1 qui est le plus fréquent, presque 80% des cas, c'est un adénocarcinome, c'est-à-dire un cancer glandulaire de l'endomètre. C'est un adénocarcinome endométrioïde, ça veut dire qu'il rappelle l'anatomopathologie, la microscopie de l'endomètre, mais avec présence des signes histologiques de malignité.

Il y a également le carcinome mucine. Le type 2, c'est un carcinome serreux papillaire, un carcinome acéryl clair et le carcinome sarco. En général, le type 1 est de bon pronostic.

Par contre, les cancers de type 2 sont de mauvais pronostics. Il faut savoir également qu'il y a le grade stop pronostic, c'est-à-dire le grade 1 qui est une tumeur bien différenciée, le grade 2 qui est une tumeur moyennement différenciée et le type 3 qui est le cancer indifférencié. Voilà un aspect d'une tumeur bourgeonnante au niveau de la cavité utérine qui est associée à un utérus polymiomateur.

Regardez les fibromes au niveau de la paroi de l'utérus. Ça, c'est une pièce d'hystérectomie totale, c'est-à-dire l'utérus, le col de l'utérus, les trompes et les ovaires. Ici, c'est une image d'une lésion hémorragique polypluïde au niveau de la cavité de l'utérus.

L'extension de la maladie se fait localement en surface, prenant pratiquement toute la cavité de l'utérus, mais surtout en profondeur, il va envahir le myomètre. Il y a également l'extension régionale vers les paramètres, vers les annexes, l'ovaire surtout, vers le péritoine, la vessie, le rectum et le vagin. Il y a également les extensions métastatiques, soit par voie lymphatique, s'il y a une atteinte de myomètre ou bien s'il y a atteinte de lysine.

Et il y a les métastases vaginales au niveau du poumon, au niveau du foie, etc. L'étude clinique, nous allons étudier un type de description assez fréquent, c'est l'adénocarcinome de la femme

ménopausée. Les signes fonctionnels sont surtout des métrorragies, très fréquentes, presque 95% des cas des femmes porteuses d'un cancer de l'endomètre vont saigner.

Ce sont des métrorragies qui sont spontanées, ce sont des métrorragies au début qui sont indolores, qui sont peu abondantes, mais il faut savoir que ces métrorragies peuvent être atypiques, qui peuvent être noirâtres, qui peuvent être douloureuses, surtout dans les cas avancés, et qui peuvent être abondantes. Il y a d'autres signes qui peuvent être associés, tels que les leucorrhées, jaunâtres ou verdâtres. En général, la femme ménopausée a rarement ces leucorrhées, donc lorsque vous avez une femme ménopausée qui présente des leucorrhées, il faut penser à diagnostiquer un cancer de l'endomètre.

Il y a les hydorrhées, un écoulement de liquide, il y a la piométrie, surtout chez les femmes ménopausées qui ont une sténose du col de l'utérus, le saignement et la tumeur qui va se surinfecter, il y a l'issue de pus de la tumeur qui ne va pas être extériorisée, il va constituer une piométrie, c'est-à-dire la cavité de l'utérus remplie de pus, c'est une poche purulente. Il y a les douleurs pelviennes et les troubles urinaires ou rectaux, mais ça, c'est dans les formes avancées. Au total, toute hémorragie génitale, toute métrorragie chez la femme ménopausée impose un bilan pour éliminer un cancer de l'endomètre.

L'examen physique, d'abord l'interrogatoire, il faut chercher les facteurs de risque, les facteurs de risque du cancer de l'endomètre, mais également il faut chercher une pathologie chronique associée, comme j'ai dit, l'asthme, bronchite chronique, cardiopathie, hypertension artérielle, diabète. L'examen physique, d'abord, il faut faire un examen somatique, j'ai dit que c'est une femme ménopausée âgée qui pourrait avoir des tumeurs associées qu'il faut les diagnostiquer parce qu'elles vont interférer avec le traitement. Vous mettez votre spéculum, le col est sain, le saignement provient de la cavité de l'utérus, donc c'est un saignement endo-utérin.

Parfois, vous pouvez avoir déjà une extension au niveau du col de l'utérus ou au niveau du vagin. Le toucher vaginal et le toucher rectal, en général gênés par une éventuelle obésité de la patiente ou bien une atrophie vaginale due à la ménopause, c'est un examen physique, en général, le toucher vaginal est souvent normal. Parfois, l'utérus est augmenté de volume.

Parfois, si dans les formes avancées, un utérus augmenté de volume est fixé, vous pouvez avoir également un envahissement des paramètres. L'envahissement des paramètres est surtout évalué par le toucher rectal. Donc, même si l'examen physique est négatif, il ne faut pas arrêter les investigations, mais il faut demander des examens complémentaires.

Les examens complémentaires, vous commencez par la cytologie. Vous faites un frottis myco-vaginal, qui est le plus souvent normal, vu que le cancer de l'endomètre est un cancer qui ne discord pas, contrairement au cancer du col de l'utérus. Vous pouvez également aller d'une brosse miniature que vous allez mettre à l'intérieur de la cavité de l'utérus.

Vous allez broser pour avoir un frottis endo-utérin. Et puis, vous ramenez des débris

cytologiques de l'endomètre. Et l'étude cytologique pourrait trouver des cellules néoplasiques.

Seulement, ce frottisseur endo-utérin n'a de valeur que s'il est positif. C'est-à-dire, si le frottisseur endo-utérin ne ramène pas de cellules cancéreuses, ça ne veut pas dire que la femme n'est pas atteinte de cancer. Le deuxième type d'examen, c'est l'histologie.

L'histologie, en général, on peut le faire par une biopsie de l'endomètre, grâce à une cannule, qu'on appelle la cannule de Novac, qu'on va mettre à l'intérieur de la cavité de l'utérus. On va ramener quelques débris de l'endomètre pour études histopathologiques. On peut avoir recours à un curtage biopsique de l'endomètre, c'est-à-dire, on fait un curtage de la cavité de l'utérus, on ramène des débris endométriaux qu'on va étudier sur le plan histologique.

Mieux encore, c'est faire une hystéroscopie, c'est-à-dire un moyen fibro-optique qu'on va mettre à l'intérieur de la cavité de l'utérus. Il va nous permettre de visualiser la lésion au niveau de la cavité, de voir la localisation de la lésion, faire une biopsie au niveau de la lésion pour études histologiques, et commencer le bilan d'extension de la lésion sur l'isthme et l'endocolle. L'échographie endovaginale, qui termine en général l'examen clinique, va vous montrer un endomètre épais.

Chez une femme inopposée, lorsque l'épaisseur de l'endomètre dépasse 5 mm, il faut obligatoirement faire une hystéroscopie pour diagnostiquer un éventuel cancer de l'endomètre. A l'échographie, vous pouvez également visualiser un bourgeon tumoral intracavitaire irrégulier, et vous pouvez également voir s'il y a un envahissement de myomètres et voir les ovaires pour voir s'il y a un éventuel métastase ovarien. La tomodensitométrie, c'est surtout pour le bilan d'extension, mais actuellement c'est l'imagerie par résonance magnétique qui est l'examen de choix pour le bilan d'extension de cancer de l'endomètre, soit l'extension myométriale, soit l'extension en dehors de l'utérus.

Voilà, en conclusion, vous avez à la clinique une femme inopposée qui va présenter des météorologies le plus souvent, vous allez faire une échographie s'il y a un épaissement de l'endomètre au-delà de 5 mm, vous allez faire une hystéroscopie avec biopsie, et pour le bilan d'extension, vous allez faire l'imagerie par résonance magnétique pelvienne ou abdominopelvienne. Après la ménopause, si la femme présente des météorologies, ce n'est pas uniquement le cancer de l'endomètre. Ça peut être un cancer du col de l'utérus, mais ici vous allez faire votre spéculum, donc vous allez voir le col de l'utérus, mais faites attention, c'est la femme inopposée, le col de l'utérus est aspiré, vous pouvez ne pas le voir par le spéculum, donc il faut avancer les investigations, surtout l'hystéroscopie.

Une atrophie de l'endomètre peut entraîner des saignements, les endométrites hémorragiques, qui sont la panache de la femme ménoposée, un polype au niveau de l'endomètre qui saigne, mais en général ça peut être un polype banal, comme ça peut être un polype qui cache un cancer de l'endomètre. Avant la ménopause, il y a le cancer du col qui est plus fréquent que le

cancer de l'endomètre, il y a des lésions cervicales telles que l'ectropion par exemple, il y a le fibrome de l'utérus, bien que nous avons dit que le fibrome donne des ménorragies, mais il y a les fibromes intracavitaires qui peuvent donner des météorologies, il y a les hyperplasies de l'endomètre et il y a les météorologies fonctionnelles, mais ce sont des diagnostics après avoir éliminé toute cause organique du saignement. Les formes cliniques, je vais parler de deux formes qui sont très intéressantes.

Premièrement, les formes de la femme qui n'est pas encore ménoposée, une femme en pré-ménopause entre 40 et 50 ans, 45-50 ans. Ce sont des femmes en général qui ont une irrégularité de cycle menstruel, donc elles peuvent saigner à n'importe quel moment et elles vont prendre le saignement comme des règles. Mais il faut faire attention parce que le diagnostic est souvent tardif, on ne pense pas assez lorsque la femme est en pré-ménopause, mais elle peut cacher un cancer de l'endomètre.

Et il y a le polype sentinelle, vous faites votre spéculo, vous trouverez un petit polype d'aspect banal qui est accouché par le corps. En général, on fait un bistournage pour enlever ce polype. Il faut faire attention chaque fois que vous avez une patiente soit en pré-ménopause ou en période d'activité génitale qui a un polype.

Si vous faites un bistournage de polype, n'oubliez pas d'explorer le reste de la cavité de l'endomètre pour éventuel cancer endométrial. Après le diagnostic qui se fait surtout par biopsie de l'endomètre et études anatomopathologiques, vous allez faire un bilan pré-thérapeutique. Il y a deux volets dans le bilan pré-thérapeutique.

D'abord, il faut explorer le terrain. C'est une femme âgée, c'est une femme ménopausée qui peut être cardiaque, qui peut être diabétique, hypertendue, bronchitique, chronique. Donc, il faut faire un examen somatique et demander les examens complémentaires pour éventuelles tâches associées, pour éventuel équilibre de diabète ou d'hypertension artérielle.

Deuxième volet de bilan pré-thérapeutique, c'est le bilan d'extension. D'abord, l'extension locorégionale. Vous faites un examen clinique.

Elle vient sous anesthésie générale. En général, on le fait au début de l'intervention chirurgicale pour traiter la patiente. Et un bilan paraclinique, radieux du thorax, une échographie ondo-vaginale, une échographie abdominale pour chercher une atteinte anxieuse, une atteinte ganglionnaire, etc.

Mais c'est surtout l'IRM qui est primordial pour l'extension myométriale et les adénopathies pelviennes et ou lombo-aortiques. Après ce bilan d'extension, vous aurez la classification de la Fédération Internationale des Gynécologues Obstétriciens, la FIGO. Cette classification, lorsqu'il est au stade zéro, ça veut dire que c'est un carcinome in situ.

Il n'a pas encore envahi la membrane basale. Le stade 1, c'est une tumeur qui est localisée au

niveau du corps de l'utérus. Il y a le 1A qui est limité à l'endomètre ou qui ne dépasse pas la moitié du myomètre.

Le 1B, c'est une invasion myométriale supérieure ou égale à 50% du myomètre. Le stade 2, c'est un cancer de l'endomètre qui va envahir le col, c'est-à-dire une atteinte du stroma endocervical. Le stade 3, c'est un cancer qui est étendu au-delà de l'utérus mais qui ne dépasse pas le pelvis de la patiente.

Le 3A, c'est une atteinte de la serreuse et ou des annexes. Le 3B, c'est une métastase vaginale et ou en paramétriale. Il y a également le stade 3C qui sont les métastases ganglionnaires.

Le 3C1, c'est les ganglions pelviens. Et le 3C2, c'est les ganglions lombo-aortiques associés ou non à des adénopathies pelviennes. Le stade 4, c'est une tumeur de l'endomètre qui dépasse le petit bassin, la vésicule ou le rectum.

Le 4A, l'atteinte du rectum ou et de la vésicule. Et le 4B, c'est les métastases à distance. Voilà un peu un schéma qui va expliquer les différents stades de la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens.

Après la stratification de la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, la FIGO, vous allez faire une classification pronostique. La classification pronostique rassemble d'abord la stratification de la FIGO, le type histologique, c'est-à-dire type 1 ou type 2, le grade histopronostique, le 1, 2 ou 3, les embouts lymphatiques. Donc il y a le risque bas lorsque c'est un stade 1A et qu'il y a un grade histopronostique 1 ou 2 et un type 1 histologique, c'est-à-dire un adénocarcinome endométrioïde ou un adénocarcinome mucineux.

Le risque intermédiaire, c'est soit un stade 1A, type histologique 1, un grade histopronostique 3, c'est-à-dire un cancer indifférencié, ou bien un stade 1B avec type histologique 1 et avec un grade histopronostique 1 ou 2. Il y a le risque élevé, c'est surtout le type histologique 1 avec un stade 1B et un grade histopronostique 3 ou un stade 1B type histologique 2 ou un stade 1 présentant des embouts lymphatiques. Cette classification pronostique ne va pas permettre que le risque de cancer, le risque d'évolution du cancer, mais également il va être une orientation de la prise en charge thérapeutique. L'évolution en général, son traitement, l'évolution va se faire.

C'est un cancer en général loco-régional, il peut envahir surtout le pelvis, mais il peut donner des métastases. Donc son traitement, soit la femme va mourir d'une hémorragie, d'une infection ou d'un envahissement ou une métastase. Sous traitement, il y a le risque de récurrence, il y a également l'échec du traitement.

Les facteurs pronostiques, c'est surtout l'âge, plus la femme est âgée, plus elle sera de mauvaise pronostic. L'opérabilité de la femme, surtout la femme qui présente des tumeurs associées qui vont restreindre le choix des moyens thérapeutiques. Bien sûr, la stratification de la figure et la classification histopronostique.

En général, le stade 1, c'est aux alentours de 80% de survie à 5 ans et le stade 4, c'est environ 10% de survie à 5 ans. La prise en charge thérapeutique repose sur la chirurgie. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut faire soit une adéno, colpo, hystérectomie et lagie.

Adéno, ça veut dire curage ganglionnaire. Colpo, ça veut dire éjection d'une collette vaginale. Hystérectomie, c'est-à-dire l'utérus avec son col.

Et lagie, ça veut dire enlever les paramètres. Et bien sûr, c'est une femme, c'est un cancer qui est hormonodépendant, donc il faut faire une ovariectomie bilatérale. Mais on peut avoir recours à uniquement une hystérectomie totale sans conservation des annexes, c'est-à-dire enlever l'utérus avec le col et les ovaires et les trompes.

Pas de curage ganglionnaire, pas de colpectomie et pas de résection des paramètres. La radiothérapie soit exclusive, soit associée à la chirurgie. L'hormonothérapie, soit par des progestatifs ou par des antihomogènes.

La chimiothérapie et bien sûr le traitement palliatif, traitement de la douleur, traitement de l'anémie, etc. Voilà quelques indications en se basant sur la classification pronostique. Lorsque le risque est faible, c'est-à-dire un adénocarcinome endométrioïde, stade 1A, grade histopronostique 1 ou 2, vous faites une hystérectomie totale avec annexectomie.

Vous pouvez faire un ganglion sentinelle. Le risque intermédiaire, c'est-à-dire adénocarcinome endométrioïde, stade 1A, mais grade 3, ou stade 1B, grade 1 et 2, dans ce cas, vous faites une hystérectomie, vous faites une annexectomie, et pour le reste, vous faites une réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire une réunion où il y a le chirurgien gynéco-oncologue, l'anatomopathologiste, le radiologue, le radiothérapeute et l'oncologue pour décider s'il faut faire ou non un curage ganglionnaire ou non, s'il faut faire une radiothérapie ou non, s'il faut faire une hormone ou une chimiothérapie ou non. Lorsque le risque est élevé, c'est-à-dire les types 2, ou bien le type 1, stade 2 ou au-delà, ou stade 1B, grade 3 histopronostique, dans ce cas, il faut obligatoirement faire une hystérectomie totale, avec une annexectomie, avec une résection des paramètres FR, un curage pelvien et l'embout aortique.

Bon, ça, c'est le schéma proposé par la Fédération internationale du gynécologue obstétricien. Lorsque vous faites d'abord un bilan d'extension, s'il n'y a pas d'atteinte de métastase, vous faites un bilan d'opérabilité. Patient opérable, dans ce cas, vous faites une hystérectomie totale sans conservation antérieure.

Si la femme n'est pas opérable, vous faites une réunion de concertation pluridisciplinaire pour décider ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire un traitement endoscopique ou un traitement symptomatique ou de la chimiothérapie? S'il y a des métastases ganglionnaires dans les deux cas, il faut faire une réunion de concertation pluridisciplinaire pour décider de traitement. Ça peut être une chimiothérapie, une radiothérapie, un traitement symptomatique, une chirurgie palliative.

Donc, voilà un peu un schéma d'orientation, mais il faut savoir qu'en cas de cancer gynécologique, une réunion de concertation pluridisciplinaire est importante. Il faut la faire et c'est au niveau de cette réunion où il faut décider quelle stratégie thérapeutique vous allez entreprendre. La surveillance après le traitement, c'est une surveillance clinique.

Une IRM si vous avez besoin. Le frottis, bon, il faut le faire, mais il n'a pas beaucoup de valeur. Il faut la faire chaque six mois pendant les deux premières années, puis une consultation par an sera suffisante pour une patiente porteuse d'un cancer de l'endomètre.